

Compte-rendu d'examens biologiques :

Dossier N° 3GLO3260092 01 du 22.11.2023

Prélevé le 22.11.2023 à 10:41 au Laboratoire

Enregistré le 22.11.2023 à 10:42

Edité le 22.11.2023 à 17:01 **COMPLET**

Prescrit par Dr ARDITTI LAURENT

75015 PARIS

Mr CHARBIT ALEXANDRE

Né(e) Mr CHARBIT ALEXANDRE

36 RUE ETIENNE MAREY

75020 PARIS

IDENTITE NATIONALE DE SANTE (INS)

Nom de naissance CHARBIT

1er prénom de naissance ALEXANDRE

Nom utilisé CHARBIT

Prénom utilisé ALEXANDRE

Date de naissance 21.03.1974 (49 Ans) Sexe : M

Lieu de naissance (INSEE) 92012 BOULOGNE-BILLANCOURT



Accréditations n°8-3243

Listes des sites et
portées disponibles sur
www.cofrac.fr

Seuls les résultats avec le signe (c) sont couverts par l'accréditation

HEMATOLOGIE

Intervalle de référence

Antécédents

Examens ci-dessous réalisés le 22.11.2023 , validés le 22.11.2023

HEMOGRAMME

Impédancemétrie-Spectrophotométrie-Cytométrie/DXH Beckman (MO) (c)

Hématies	5,20	T/L	4,60 à 6,20
Hémoglobine	14,6	g/dL	13,0 à 18,0
Hématocrite	44,2	%	40,0 à 54,0
V.G.M	85	fL	79 à 97
T.C.M.H	28,1	pg	27,0 à 32,0
C.C.M.H	33,0	g/dL	31,0 à 36,0
I.D.C	12,9	%	12,3 à 17,0
Leucocytes	5 200	/mm3	4 000 à 11 000
Neutrophiles	54,2 % soit 2 818	/mm3	1 500 à 7 500
Eosinophiles	3,2 % soit 166	/mm3	Inf.à 600
Basophiles	0,6 % soit 31	/mm3	Inf.à 200
Lymphocytes	32,7 % soit 1 700	/mm3	1 100 à 4 400
Monocytes	9,3 % soit 484	/mm3	200 à 800
Plaquettes	217 000	/mm3	150 000 à 400 000
Impédancemétrie/DXH Beckman (MO) (c)			
VMP	8,6	fL	7,5 à 11,2

DR PAUC EVELYNE

Biologiste

L'étoile " * " signale un résultat en dehors des valeurs de référence.

Compte-rendu d'examens biologiques de: **Mr CHARBIT ALEXANDRE**
 Né(e) **CHARBIT** 36 RUE ETIENNE MAREY
 Date de naissance: **21.03.1974** (49 Ans)
 Dossier N° **3GLO3260092 - 01** du **22.11.2023** 75020 PARIS
 Prélevé le 22.11.2023 à 10:41 / Edité le 22.11.2023 à 17:01

HEMOSTASE ET COAGULATION

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES CONCERNANT LE BILAN D'HEMOSTASE

Examens ci-dessous réalisés le 22.11.2023 , validés le 22.11.2023

Traitement **absence de traitement influençant le bilan d'hémostase**

FACTEUR V **72** % **62 à 139**

Méthode chromométrique/ACL-TOP WERFEN (3S) (c)

BIOCHIMIE SANGUINE

Intervalle de référence

Antécédents

Examens ci-dessous réalisés le 22.11.2023 , validés le 22.11.2023

PROTEINE C REACTIVE (CRP) **2** mg/L **Inf. à 5**

Immuno-turbidimétrie/AU5800 Beckman (MO) (c)

GLYCEMIE **0,85** g/L **0,70 à 1,10**

Hexokinase/AU5800 Beckman (MO) (c)

soit

4,72 mmol/L

HEMOGLOBINE GLYQUEE (HBA1C) **5,0** %

IFCC

32 mmol/mol

HPLC standard NGSP-DCCT/D100 Biorad (3S) (c)

Interprétation

Objectifs Suivi HbA1C (Recommandations HAS)		Dépistage (Recommandations OMS, EADS, ADA, IDF)
Diabète de type 1	HbA1c < 7,5% : Diabète équilibré	HbA1c < 5,7% : Risque faible de diabète HbA1c entre 5,7% et 6,4% : Pré-diabète possible HbA1c > ou = 6,5% : Diagnostic de diabète
Diabète de type 2	HbA1c < ou = 7,0% : Diabète équilibré	
	HbA1c > 7,0% : Diabète non équilibré sauf patients "fragiles" : pathologies chroniques, complications macrovasculaires, IRC sévère.	



DR PAUC EVELYNE
 Biologiste

Compte-rendu d'examens biologiques de: **Mr CHARBIT ALEXANDRE**
Né(e) **CHARBIT** 36 RUE ETIENNE MAREY
Date de naissance: **21.03.1974 (49 Ans)**
Dossier N° **3GLO3260092 01** du **22.11.2023** 75020 PARIS
Prélevé le 22.11.2023 à 10:41 / Edité le 22.11.2023 à 17:01

BIOCHIMIE SANGUINE

Intervalle de référence

Antécédents

Examens ci-dessous réalisés le 22.11.2023 , validés le 22.11.2023

CREATININEMIE **10,2** mg/L 7,2 à 11,8
soit 90 μ mol/L 64 à 104

Enzymatique/AU5800 Beckman (MO) (c)

DFG estimé selon l'équation CKD-EPI **86** mL/min/1,73m² >90

Calcul recommandé par la HAS 2012 du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)

Le résultat de DFG est à multiplier par 1,15 pour les sujets à peau noire.

L'équation CKD-EPI n'est pas encore complètement validée pour les patients de plus de 75 ans,
et pour les patients dénutris ou en surpoids ou ayant une alimentation pauvre en protéines animales.

DFG estimé par la formule MDRD **78** mL/min/1,73m² >90

Débit de Filtration Glomérulaire (DFG)

Le résultat de DFG est à multiplier par 1,21 pour les sujets à peau noire.

Les 5 stades de la maladie rénale chronique - HAS 2012 et KDIGO 2012 (DFG en mL/min/1,73m²)

Stade 1	> ou = 90	Marqueurs d'atteinte rénale (*) avec DFG normal ou augmenté
Stade 2	60 à 89	Marqueurs d'atteinte rénale (*) avec DFG légèrement diminué
Stade 3A	45 à 59	Insuffisance rénale chronique minime à modérée
Stade 3B	30 à 44	Insuffisance rénale chronique modérée à sévère
Stade 4	15 à 29	Insuffisance rénale chronique sévère
Stade 5	< 15	Insuffisance rénale chronique terminale

(*) marqueurs d'atteinte rénale : albuminurie, hématurie, leucocyturie ou anomalies morphologiques ou histologiques, ou marqueurs de dysfonction tubulaire persistant pendant plus de 3 mois (2 à 3 examens consécutifs).

ALBUMINE SERIQUE **43,1** g/L 38,4 à 46,9

Bromocrésol/AU5800 Beckman (MO) (c)

EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE**ASPECT****Limpide**

TRIGLYCERIDES **0,86** g/L 0,45 à 1,50

GPO POD/AU5800 Beckman (MO) (c)

soit 0,98 mmol/L 0,51 à 1,71

* **CHOLESTEROL TOTAL** **2,35** g/L 1,40 à 2,15

* Cholestérol oxydase-PAP/AU5800 Beckman (MO) (c) *soit* 6,09 mmol/L 3,63 à 5,57

CHOLESTEROL HDL **0,49** g/L Sup. à 0,40

Enzymatique/AU5800 Beckman (MO) (c)

soit 1,27 mmol/L Sup. à 1,04

RAPPORT TOTAL/HDL **4,8** Inf à 5,0

CHOLESTEROL LDL **1,69** g/L

Selon la formule de Friedewald (MO) (c)

soit 4,38 mmol/L

DR PAUC EVELYNE
Biologiste

Compte-rendu d'examens biologiques de: **Mr CHARBIT ALEXANDRE**
 Né(e) **CHARBIT** 36 RUE ETIENNE MAREY
 Date de naissance: **21.03.1974 (49 Ans)**
 Dossier N° **3GLO3260092 - 01** du **22.11.2023** 75020 PARIS
 Prélevé le 22.11.2023 à 10:41 / Edité le 22.11.2023 à 17:01

BIOCHIMIE SANGUINE

Intervalle de référence

Antécédents

Prise en charge des dyslipémies en prévention primaire (HAS, Février 2017)

L'évaluation du risque cardiovasculaire (RCV) dans la population générale est fondée sur les tables SCORE (%), ou à défaut par le décompte des facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) :

AGE : homme > ou = 50 ans, femme > ou = 60 ans ; ANTECEDENTS FAMILIAUX cardiovasculaires ischémiques (homme < ou = 55ans, femme < ou = 60ans)

TABAGISME actif ou arrêté depuis moins de 3 ans ; HYPERTENSION ARTERIELLE ; HDLc < ou = 0,40g/L ; DIABETE de type 2 ou diabète de type 1 de plus de 15 ans d'évolution ;

INSUFFISANCE RENALE (DFG < 45 ml/min, < 60 ml/min chez l'adulte jeune)

Niveaux de RCV et taux de LDL-C pouvant déclencher une décision thérapeutique

SCORE (%) ou FRCV	RCV	Taux de LDL-C
<1% ou 0-1 FRCV	Faible	> 1,9 g/L
1 <= score < 5% ou 2 FRCV	Intermédiaire	> 1,3 g/L
>= 5% ou 3 FRCV	Elevé	> 1,0 g/L
Diabétique avec atteinte des organes cibles ou avec plus de 2 FRCV	Très élevé	> 0,7 g/L

Des mesures hygiéno-diététiques sont préconisées si LDL-C > 1,3 g/L ou triglycéridémie > 1,5 g/L

Remarque :

Un taux de LDL-C > ou = à 1,9 g/L (4,9 mmol/L) en présence d'antécédents familiaux d'hypercholestérolémie et d'accidents cardiovasculaires doit faire évoquer une hypercholestérolémie familiale.

Examens ci-dessous réalisés le 22.11.2023 , validés le 22.11.2023

TRANSAMINASES (SGOT-ASAT) 31 UI/L Inf. à 50
 IFCC avec P5P/AU5800 Beckman (MO) (c)

TRANSAMINASES (SGPT-ALAT) 46 UI/L Inf. à 50
 IFCC avec P5P/AU5800 Beckman (MO) (c)

PHOSPHATASES ALCALINES 59 UI/L 30 à 120
 IFCC tampon AMP/AU5800 Beckman (MO) (c)

GAMMA-GT 26 UI/L Inf. à 55
 IFCC/AU5800 Beckman (MO) (c)

Calcul SCORE Fibrosis-4 (FIB-4) 1,03 Inf. à 1,3
Méthode non invasive d'évaluation de la fibrose hépatique.

Interprétation

<1,3	<i>Pas de maladie hépatique sévère</i>
1,3 à 2,67	<i>Surveillance hépatique</i>
> 2,67	<i>Avis en hépatologie après confirmation par tests sanguins spécialisés ou par élastométrie.</i>

Le score FIB4 n'est pas utilisable en cas de cytolysé hépatique connue ou de thrombopénie ou chez les patients de plus de 70 ans.

LDH 136 U/L Inf. à 247
 Lactate-pyruvate 340 nm-37°C/AU5800 Beckman (MO) (c)



DR PAUC EVELYNE
 Biologiste

Compte-rendu d'examens biologiques de: **Mr CHARBIT ALEXANDRE**
Né(e) **CHARBIT** 36 RUE ETIENNE MAREY
Date de naissance: **21.03.1974** (**49 Ans**)
Dossier N° **3GLO3260092 01** du **22.11.2023** 75020 PARIS
Prélevé le 22.11.2023 à 10:41 / Edité le 22.11.2023 à 17:01

MARQUEURS

Examens ci-dessous réalisés le 22.11.2023 , validés le 22.11.2023

PSA TOTAL **0,77** ng/mL **inf. à 4**

Immuno-chimiluminescence-Hybritech®/DXi Beckman (MO) (c)

TABLEAU D'INTERPRETATION DU PSA TOTAL (PSAt)

<i>PSAt < 2,5 ng/ml</i>	<i>Le PSAt est statistiquement normal. En fonction des facteurs de risque un contrôle annuel est conseillé.</i>
<i>2,5 ng/mL < PSAt < 4 ng/mL</i>	<i>En fonction des facteurs de risque et de la clinique, le dosage du PSA libre est conseillé.</i>
<i>4 ng/mL < PSAt < 10 ng/mL</i>	<i>Le dosage du PSA libre est souhaitable.</i>
<i>PSAt > 10 ng/mL</i>	<i>Des examens complémentaires, autres que biologiques sont nécessaires.</i>

DR PAUC EVELYNE
Biologiste

L'étoile " * " signale un résultat en dehors des valeurs de référence.

Examens effectués par : (LO) LBM LOGNES- 9 ESPLANADE DRTS DE L HOM ME- 77185 LOGNES-N° 773706676

(MO) LBM MONTEVRAIN- 19/21 ROUTE DE PROVINS- 77144 MONTEVRAIN-N° 773706767

(3S) LBM TROIS SOURCES- 1 CHEMIN DES 3 SOURCES- 95290 ISLE-ADAM-N° 95370198

LBM sous traitants : (3S)

Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans autorisation écrite du laboratoire

** Fin de compte rendu ** **Page 5 / 5**